

Madame A.B, âgée de 25 ans, est admise aux urgences pour altération de l'état général avec vomissements et douleurs abdominales. En un mois, elle a perdu 6 kg (elle pèse 54 kg pour 168 cm). Elle buvait ces derniers jours près de 5 litres d'eau par jour et urinait très souvent. Elle n'a aucun autre antécédent pathologique. Elle est normalement réglée sous contraceptifs oraux et ne fume pas. À l'examen clinique : asthénie, un peu confuse et obnubilée, la pression artérielle est à 90/50 mmHg ; le pouls à 100/min ; la fréquence respiratoire à 26 cycles/min ; la température à 37,9°C. Les extrémités sont froides, la langue sèche, il existe un pli cutané. L'auscultation cardio-pulmonaire est sans particularité : pas de signes d'insuffisance cardiaque droite. L'abdomen est souple sans masse palpable. Les bruits hydro-aériques sont perçus. L'examen neurologique sans anomalie.

Biologie : Glycémie capillaire à 3,9 g/L ; NFS : hémoglobine : 14 g/100 mL ; GB : 15 000/mm³ ; sérum lactescent ; Na⁺ : 140 mmol/L ; K⁺ : 5,3 mmol/L ; Cl⁻ : 110 mmol/L ; HCO₃⁻ : 12 mmol/L ; pH : 7,2 ; urée : 23 mmol/L ; créatinine : 150 µmol/L. BU : glucose +++++, acétone +++++.

16. Quel diagnostic évoquez-vous ?

- A. Coma hyperosmolaire.
- B. Cétose diabétique.
- C. Cétosidose diabétique.
- D. Cétose de jeûne.
- E. Acidose lactique.

C Définition de la ceto-acidose diabétique :

Il s'agit d'un désordre métabolique, hydrique et électrolytique caractérisé par :

- Glycémie $\geq 2,5\text{g/l}$
- Cétonémie $> 3 \text{ mmol/l}$ ou cétonurie positive ($\geq ++$)
- glycosurie $\geq ++$
- acidose (pH artériel $< 7,30$)

17. Les signes cliniques de déshydratation extracellulaire sont :

1. Sécheresse des muqueuses.

2. Pli cutané.

3. Hypotension.

4. Soif intense.

5. Perte de poids.

A. (1+3+4) B. (2+5+4) C. (2+3+5) D. (1+2+3+4) E.(1+2+5)

C

Déshydratation extracellulaire

Signes cliniques

- Hypotension artérielle orthostatique
- Tachycardie
- État de choc
- Aplatissement des veines superficielles
- Oligurie
- Perte de poids
- Pli cutané
- Soif
- Yeux enfoncés, cerné et hypotonie des globes

18. Quels examens paracliniques manquent-ils dans l'observation ?

1. Radiographie du thorax.

2. Échographie abdomino-pelvienne.

3. Électrocardiogramme.

4. Examen cytot bactériologique des urines.

5. Le taux de peptide C.

A. (1+3+4) B. (1+3+4+5) C. (1+2+3+4) D. (3+4+5) E.
(1+2+5)

A Examens complémentaires à demander en urgence sont :

>Biologiques :

- glycémie veineuse
- Urée, Créatininémie
- ionogramme sanguin ++++++
- FNS systématique

>Morphologiques :

- ECG +++++
- TLT

>Au besoin : Troponines, hémoculture, ECBU,

19. Quels sont les principes du traitement chez cette patiente durant les premières heures ?

1. Réhydratation orale.
2. Insulinothérapie intraveineuse.
3. Réhydratation parentérale par du sérum salé isotonique.
4. Schéma basal-bolus d'insuline.
5. Supplémentation potassique.

- A. (1+2+3)
- B. (2+3+4+5)
- C. (2+3+5)
- D. (1+2+3+5)
- E. (2+3)

E Le traitement dans la ceto-acidose diabétique se base sur la réhydratation parentérale pour compenser la perte hydrique avec l'insulinothérapie intraveineuse pour empêcher la genèse des corps cétoniques

20. Quels sont les éléments de surveillance ?

1. Glycémie chaque heure.
2. Bandelettes urinaires chaque heure.
3. Ionogramme et ECG chaque quatre heures.
4. Triglycérides et lipasémie.
5. État clinique, fréquences cardiaque et respiratoire.

- A. (1+2+3+4+5)
- B. (1+2+3+5)
- C. (1+2+3)
- D. (1+2+4+5)
- E. (1+2+3+4)

B -la surveillance dans l'acidocétose diabétique est :

***clinique** toutes les 30 minutes pendant 4 heures puis chaque 4 heures :

- Pouls et PA, fréquence respiratoire, état de conscience
- Diurèse, glycosurie et cétonurie
- Glycémie capillaire

***Biologique** :

- Ionogramme sanguin immédiat puis toutes les 3 heures
- Créatinine
- Gaz du sang répétés si acidose sévère au début

***ECG** : toutes les 4 à 6h

